

Hepatitis agudas y crónicas

1. Introducción y relevancia clínica

La **hepatitis** es un proceso inflamatorio del hígado causado por agentes infecciosos, tóxicos o autoinmunes, que puede presentarse en forma **aguda o crónica**.

A nivel clínico, se caracteriza por elevación de las transaminasas, ictericia y alteraciones en las pruebas hepáticas.

Las hepatitis virales constituyen un importante problema de salud pública, dado que son **causa principal de cirrosis y carcinoma hepatocelular** a nivel mundial.

En Chile, la prevalencia de hepatitis A ha disminuido gracias a la vacunación y mejoras sanitarias, mientras que las hepatitis B y C siguen siendo foco de vigilancia epidemiológica.

Según la **OMS (2024)**, alrededor de **354 millones de personas en el mundo** viven con hepatitis B o C crónicas.

El **MINSAL** mantiene un programa nacional de pesquisa, tratamiento y seguimiento para **hepatitis virales B y C**, y de **vacunación universal contra hepatitis B** desde 2005.

En el **EUNACOM**, este tema es frecuente por su relevancia en salud pública, su relación con otras patologías (cirrosis, hepatocarcinoma) y porque integra conceptos clínicos, bioquímicos y epidemiológicos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El hígado cumple funciones esenciales en el metabolismo, la detoxificación y la síntesis de proteínas plasmáticas.

La **hepatitis aguda** se produce por una **respuesta inflamatoria difusa y reversible**, mientras que la **hepatitis crónica** implica una inflamación persistente (>6 meses) con destrucción progresiva del parénquima hepático, fibrosis y riesgo de cirrosis.

2.1. Hepatitis aguda

Causada principalmente por **virus hepatotropos (A, B, C, D, E)**, aunque también puede deberse a tóxicos (paracetamol, alcohol), fármacos o mecanismos autoinmunes.

El daño se genera por la **respuesta inmune del huésped** contra hepatocitos infectados, más que por el efecto directo del virus.

2.2. Hepatitis crónica

Corresponde a inflamación hepática mantenida, generalmente por **virus B o C**, que produce **necrosis y fibrosis progresiva**.

El resultado final puede ser **cirrosis hepática** o **carcinoma hepatocelular (CHC)**.

2.3. Virus hepatotropos principales

Virus	Tipo	Transmisión	Curso
A	RNA	Fecal-oral	Aguda, autolimitada
B	DNA	Sexual, sanguínea, vertical	Aguda o crónica
C	RNA	Parenteral	Crónica
D	RNA	Coinfección con B	Crónica, severa
E	RNA	Fecal-oral	Aguda (grave en embarazadas)

(Nota: solo para referencia explicativa, no como tabla de examen)

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La mayoría de las hepatitis agudas son **asintomáticas o leves**.

Cuando se manifiestan, el cuadro clínico pasa por **tres fases**:

3.1. Fase prodrómica

- Malestar general, astenia, mialgias.

- Anorexia, náuseas, vómitos.
- Fiebre baja, molestias en hipocondrio derecho.
- En hepatitis A: puede haber fiebre y síntomas gastrointestinales intensos.

3.2. Fase ictérica

- Ictericia progresiva (piel y mucosas amarillas).
- Coluria (orina oscura).
- Acolia (heces claras).
- Hepatomegalia dolorosa.
- Prurito leve.

3.3. Fase de resolución o convalecencia

- Disminución de la ictericia.
- Persistencia de astenia por semanas.

En casos graves puede haber **hepatitis fulminante**, definida como **encefalopatía hepática y coagulopatía** dentro de las 8 semanas de inicio de síntomas, con mortalidad >70% sin trasplante.

4. Diagnóstico

4.1. Laboratorio hepático

- **Transaminasas (ALT/AST):** elevación marcada (>10 veces el valor normal en hepatitis aguda).
 - ALT > AST en hepatitis viral.
 - AST > ALT en daño alcohólico.
- **Bilirrubina total y directa:** aumentadas en fase ictérica.

- **Fosfatasa alcalina y GGT:** elevadas si hay colestasis.
 - **Tiempo de protrombina (TP):** prolongado indica disfunción hepática grave.
 - **Albúmina:** disminuida en enfermedad crónica.
-

4.2. Serologías específicas

Hepatitis A

- Anti-VHA IgM positivo → infección aguda.
- Anti-VHA IgG positivo → inmunidad previa o vacunación.

Hepatitis B

- HBsAg (+): infección activa.
- Anti-HBc IgM (+): infección aguda.
- Anti-HBc IgG (+): infección pasada o crónica.
- Anti-HBs (+): inmunidad (por vacuna o infección previa).
- HBeAg (+): alta replicación viral.

Interpretación práctica:

- HBsAg (+) > 6 meses → hepatitis crónica B.

Hepatitis C

- Anti-VHC (+): exposición al virus.
- ARN-VHC (+): infección activa.
- Si ARN-VHC (-): infección resuelta.

Hepatitis D

- Solo ocurre en coinfección o sobreinfección con virus B.

- Diagnóstico: anti-HDV IgM/IgG o ARN-HDV.

Hepatitis E

- Diagnóstico: anti-HEV IgM (fase aguda).
 - Particularmente grave en embarazadas.
-

5. Diagnóstico diferencial

- **Colestasis obstructiva (cálculos biliares, tumores):** coluria y acolia, pero fosfatasa alcalina y GGT muy elevadas.
 - **Hepatitis medicamentosa:** relación temporal con fármacos (paracetamol, isoniazida, valproato, amoxicilina-clavulánico).
 - **Hepatitis autoinmune:** ANA o anti-SM positivos, hipergammaglobulinemia, respuesta a corticoides.
 - **Esteatohepatitis no alcohólica:** transaminasas moderadamente elevadas, sin ictericia.
 - **Síndrome de Gilbert:** hiperbilirrubinemia aislada, sin daño hepático.
-

6. Tratamiento (según Guías MINSAL y OMS 2024)

El tratamiento depende del agente etiológico y del grado de compromiso hepático.

6.1. Medidas generales

- Reposo relativo durante la fase sintomática.
 - Dieta equilibrada, evitando alcohol, fármacos hepatotóxicos y AINEs.
 - Control de transaminasas y coagulación.
 - En hepatitis A o E, el manejo es **sintomático**, con recuperación completa.
-

6.2. Tratamiento específico

Hepatitis A

- No requiere antivirales.
- Manejo de soporte: hidratación, dieta y control clínico.
- Prevención con vacuna (2 dosis, MINSAL desde 2018 en población de riesgo).

Hepatitis B

- La mayoría de los adultos se curan espontáneamente.
- Indicar tratamiento antiviral en:
 - Formas fulminantes o crónicas activas.
 - ALT >2 veces el límite normal + ADN-VHB elevado.
 - Evidencia de fibrosis hepática.

Fármacos antivirales:

- Tenofovir o entecavir (potentes y con bajo riesgo de resistencia).
- Duración: prolongada o indefinida según respuesta.

Hepatitis C

- Se trata con **antivirales de acción directa (AAD)**: combinación oral de sofosbuvir + velpatasvir o glecaprevir + pibrentasvir.
- Duración habitual: **8 a 12 semanas**.
- Eficacia >95 % (curación virológica sostenida).
- Tratamiento disponible en Chile a través del programa MINSAL para casos confirmados.

Hepatitis D

- Se maneja junto con hepatitis B.

- Antivirales con interferón pegilado alfa (respuesta variable).
- Prevención: vacunación anti-VHB.

Hepatitis E

- No hay tratamiento antiviral estándar.
 - En casos graves o inmunocomprometidos: ribavirina.
-

6.3. Hepatitis autoinmune

- Corticoides (prednisona 1 mg/kg/día) + azatioprina.
 - Duración: largo plazo, con monitoreo hepático.
-

7. Seguimiento y evolución

7.1. Hepatitis aguda

- Control clínico y de laboratorio hasta normalización de transaminasas.
- Evitar alcohol y fármacos hepatotóxicos durante 6 meses.

7.2. Hepatitis crónica

- Seguimiento semestral o anual con:
 - Pruebas hepáticas (ALT/AST, bilirrubina, TP).
 - Ecografía hepática (detección de fibrosis o CHC).
 - Alfafetoproteína (marcador de hepatocarcinoma).
 - Evaluación de contactos y vacunación familiar.

Evolución posible:

- Curación espontánea.
 - Portador inactivo (en hepatitis B).
 - Cirrosis o carcinoma hepatocelular (sin tratamiento).
-

8. Complicaciones

- **Hepatitis fulminante:** necrosis masiva hepática, con encefalopatía y coagulopatía.
 - **Cirrosis hepática:** fibrosis avanzada, hipertensión portal, ascitis, várices.
 - **Carcinoma hepatocelular:** complicación tardía de hepatitis B y C crónicas.
 - **Colestasis prolongada:** prurito e ictericia persistente.
 - **Coagulopatía:** por déficit de factores de coagulación dependientes de vitamina K.
-

9. Prevención

1. Vacunación:

- **Hepatitis A:** recomendada en niños y grupos de riesgo.
- **Hepatitis B:** esquema universal (0, 2 y 6 meses).
- No existe vacuna para hepatitis C ni E (salvo en desarrollo).

2. Medidas de bioseguridad:

- Uso de preservativo y material estéril.
- No compartir agujas ni elementos cortopunzantes.
- Tamizaje de sangre donada.

3. Educación sanitaria: evitar consumo de agua contaminada y alimentos crudos.

4. Control de portadores: seguimiento y tratamiento oportuno.

10. Pronóstico

- **Hepatitis A y E:** recuperación completa, sin secuelas.
- **Hepatitis B:** 90–95 % de adultos eliminan el virus espontáneamente; el resto puede evolucionar a cronicidad.
- **Hepatitis C:** con antivirales modernos, >95 % se curan.
- **Hepatitis D:** curso más agresivo, con riesgo alto de cirrosis.
- **Hepatitis autoinmune:** buen pronóstico con tratamiento mantenido.

El pronóstico depende de la etiología, edad, comorbilidades y adherencia al tratamiento antiviral.

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **hepatitis A** se transmite por vía fecal-oral y nunca se cronifica.
2. La **hepatitis B y C** pueden hacerse crónicas y evolucionar a cirrosis y cáncer hepático.
3. El **diagnóstico se basa en serologías virales específicas** y elevación de ALT/AST.
4. La **vacuna anti-VHB** previene también la hepatitis D.
5. En hepatitis aguda, el **manejo inicial es de soporte**, evitando hepatotóxicos.
6. El **tratamiento de hepatitis C** actual con antivirales de acción directa logra >95 % de curación.
7. En EUNACOM, suelen preguntar interpretación de serologías y elección de tratamiento.

Errores comunes:

- Diagnosticar hepatitis viral sin descartar causas medicamentosas.
 - No indicar antivirales en hepatitis B crónica activa.
 - Olvidar tamizaje de hepatocarcinoma en portadores crónicos.
 - Omitir vacunación en contactos.
 - Considerar erróneamente que todas las hepatitis se hacen crónicas.
-

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hepatitis aguda** es inflamación hepática reversible, mientras que la **crónica** implica inflamación persistente >6 meses.
2. *Hepatitis A y E* → transmisión fecal-oral, curso agudo.
3. *Hepatitis B y C* → transmisión parenteral o sexual, riesgo de cronicidad.
4. El **diagnóstico se basa en serologías específicas y pruebas hepáticas**.
5. **Tratamiento antiviral:** tenofovir o entecavir (VHB), sofosbuvir + velpatasvir (VHC).
6. La **vacunación contra hepatitis B** es la principal medida preventiva.
7. El **seguimiento periódico** es clave para prevenir cirrosis y hepatocarcinoma.